

05 - 01-Anatomie de l'orbite - Pr. KRIET

Chers étudiants et étudiantes, bonjour. Nous allons introduire l'étude de l'anatomie 4, la partie thermologie. Nous abordons plusieurs chapitres.

Tout d'abord, l'étude de l'anatomie de l'oblique. Puis, nous allons par la suite traiter les annexes du globe oculaire. Dans un premier temps, les paupières.

Puis, le système d'acryma, la conjonctive. Et enfin, les muscles oculomoteurs. L'orbite osseuse sont deux cavités quadrangulaires.

Elles contiennent les bulles oculaires, les muscles oculomoteurs, les nerfs, la graisse orbitaire et les vaisseaux sanguins. Ils sont situés de chaque côté de la racine nez, entre les os du crâne et ceux de la face. Chaque orbite est constituée par l'ensemble des os de voisinage, qui sont en nombre de sept.

L'os finida, la petite et la grande aile. L'os malaire. L'os éthmoidal.

L'os frontal. L'os palatin. L'os maxillaire.

Et l'os lacrymal. Sur cette coupe, vous voyez ici, l'orbite se forme de bois. Il filait vers l'arrière au niveau de l'apex orbitaire du crâne atlantique.

Il se situe de chaque côté de la racine du nez, entre les os du crâne et les os de la face. Alors, pourquoi l'étude de l'orbite ? D'abord, sur le plan anatomique, des rapports qui contiennent avec la force cérébrale antérieure. Les ménages, les sinuses frontales en haut, les sinuses maxillaires en bas.

Et les sinuses finidales en arrière, puis le labyrinthe éthmoidal. Sur le plan physiologique, le rôle de l'orbite, donc de protection du globe oculaire et leurs annexes. Les ménages lacrymaux et l'expression mimique.

En plus, plusieurs pathologies qui peuvent intéresser l'orbite, à savoir les pathologies inférieures, la pathologie inflammatoire, tumoral et traumatique. L'anatomie descriptive de l'orbite. L'orbite a la forme triangulaire à la coupe, à base antérieure et à sommet postérieur.

La base ici, conscrute par le robot orbital en avant, est présente à décrire quatre parois. La paroi supérieure, au bas de l'orbite. La paroi inférieure, au plancher de l'orbite.

La paroi interne. La paroi externe. Ces parois sont séparées par quatre angles.

Donc le support interne et le support externe. Un ferroi interne et un ferroi externe. Et quatre robots orbitaires.

Ici, vous voyez l'orbite. Donc le plancher, le plancher de l'orbite. La paroi inférieure.

La paroi supérieure, au toit de l'orbite. La paroi externe. Et la paroi interne, sur le schéma de l'orbite droit.

L'orientation et la monture de l'orbite dans le sens antérieur ou extérieur. La profondeur de l'orbite est de 40 mm en moyenne. L'orifice antérieur ou la base de l'orbite.

L'orifice antérieur ou la base de l'orbite. Mesure 40 mm de large. Pour 35 mm de hauteur.

La distance qui sépare les deux orbites au espace intercontact. Est de 25 à 33 mm chez l'adulte. Le volume de la cavité.

Estimée en moyenne entre 26 et 28 cm. Sur cette coupe, vous voyez ici qu'on appelle l'espace intercontact. Elle est 25 mm chez l'adulte.

Et l'angle qui fait la paroi interne. Avec la paroi externe. Est environ 40 degrés.

Par quoi est construite l'orbite? D'abord, la paroi orbitaire. Ils sont recouverts en dedans par une couche fibreuse. Une couche fibreuse.

Elle recouvre le périoste des os orbitaires. Au niveau de l'apex orbitaire. Ion avec la dure mer qui recouvre le roton.

La paroi supérieure. Il est la forme d'un triangle à base antérieure. Cette paroi est constituée derrière, en avant.

Par la petite aile de l'os sphénoïdale. La portion horizontale de l'os frontal. Ces deux os sont séparés par la structure sphénoïdale frontale.

Dans sa partie, sa portion antérieure frontale. Le toit devient plus convexe. Et présente deux éléments anatomiques.

En dehors, la force de la grande et de celui. La force de la grande et de celui. Iron dedans la fausse anculaire.

L'épaisseur de toit de l'orbite est d'environ un millimètre. Séparant la partie antérieure du contenu orbitaire. Cette paroi contracte également un rapport latine.

Avec le sinus frontal. Sur ce schéma, la vue inférieure de la paroi supérieure de l'orbite bouge. Vous voyez ici la composition de la paroi supérieure.

Par les deux os frontaux en avant. Et la petite aile du sinus en arrière. Ici, deux repères anatomiques très importants.

La fausse anculaire. La fausse anculaire de l'orbite supérieure. Et la fausse de la blonde lacrymale.

En haut et en dehors. Sur cette coupe de la paroi supérieure de l'orbite d'en haut. Vue inférieure.

Vous voyez ici la forme du toit de l'orbite. Il est triangulaire à la coupe. La paroi supérieure et l'anatomique supérieure.

Deux os. Frontale. Et la petite aile du sinuïde.

Qui sont séparées par la structure sinus frontale. Ici. C'est la faussette lacrymale postulose.

La blonde lacrymale principale. Et la faussette anculaire. Où s'insère le tendon de l'orbite supérieure.

La structure fronto-sinuïdale. La structure fronto-sinuïdale. Par la portion horizontale de l'orbite.

Et la petite aile du sinuïde. La paroi externe. La paroi externe.

Il a la forme aussi triangulaire. A base antérieure. Cette paroi est formée par trois os.

Derrière et en avant. La grande aile du sinuïde. En avant et en bas.

L'os malaire. En avant et en haut. L'os frontal.

Ces trois os sont réunis par deux structures. Que l'on appelle les structures fronto-malaires. Et les structures sino-malaires.

Elles constituent la paroi la plus solide. La plus épaisse des parois orbitaires. En arrière et un peu au-dessus de la structure fronto-malaire.

On trouve le tubercule de Wittnall. Qui donne l'insertion au ligament palvibril interne. Ce paroi est au contraire du rapport.

Avec la force temporale en avant. Et l'étage moyen de la base du crâne en arrière. Sur cette coupe de la paroi externe de l'orbite.

Ou paroi latérale de l'orbite. Elle est composée par l'os malaire. En avant et en bas.

L'os frontal. En avant et en haut. Et la grande aile de Sphinouïde.

En arrière. Donc elle est composée par trois os. L'os malaire.

Les os malaires. Les os domestiques. En avant et en bas.

L'os frontal. En haut et en avant. Et la grande aile de Sphinouïde.

En arrière. Ces os n'avaient pas de structure. Ils n'avaient que des structures.

Fronto-malaires. Et Sphinou-malaires. Structures.

Sphino-malaires. Et structures. Fronto-malaires.

La paroi inférieure au plancher d'orbite. De forme triangulaire. Donc la paroi.

C'est une paroi très fragile. Elle a une épaisseur de 0,5 mm. C'est par le contenu orbital.

De celui du maxillaire. Elle est constituée par trois os. L'os zygomatique.

En avant. Et en dehors. L'os maxillaire.

En avant. Et en dedans. Le processus.

C'est un os orbital de palata. En arrière. Donc il est composé par trois os.

Comme la paroi latérale. Cette paroi est le siège du sillon. Sur-orbitaire.

Il s'étend derrière. En avant. Puis converti en canal.

Dans sa partie. La partie. Ou sa moitié antérieure.

Et il contraint le rapport. Avec l'os maxillaire. Sur cette coupe.

Des planchers de l'orbite. Droits. Du supérieur.

Vous voyez ici. La composition osseuse. L'os zygomatique.

En avant. Et en dehors. L'os maxillaire.

En avant. Et en dedans. Et on appelle le processus.

Orbitaire. De l'os palata. Trois os.

Qui composent la paroi. Antérieure. Au plancher d'orbite.

L'os maxillaire. En avant. Et en dedans.

L'os zygomatique. En avant. Et en dehors.

Et l'os palata. En arrière. Alors.

C'est un os. Paroi. Et le siège.

Sur orbitaire. Le siège. Sur orbitaire.

Il s'étend. Derrière. Il s'étend.

Derrière. En avant. Puis.

Il se convertit. En canal. En canal.

Dans sa partie. Dans sa moitié. Antérieure.

Ici. Il s'ouvre. Entre.

Dans l'os. Maxillaire. En avant.

Et en dedans. Par le. On appelle.

Le canal. Infraorbitaire. Qui contient.

La terre. Infraorbitaire. Et les branches.

Maxillaire. De neutre. Très jumeau.

La paroi. Interne. Il a la forme.

Du quadrilatère. Cette paroi. Est formée.

Derrière. En avant. Par une partie.

De la face latérale. De corpus. Fluide.

La lame. Pupérassée. Au os.

Planum. De la détruite. L'os lacrimonas.

Olympus. Et la profuse. Orbitaire.

De l'os. Maxillaire. Sur.

Cette coupe. De l'orbite. Droite.

Du latéral. De la paroi. Donc.

La composition. Cette paroi. Elle n'est pas.

Formée. Par l'os. Fimidal.

En arrière. L'os. Lacrimonas.

Et la profuse. Orbitaire. De l'os.

Maxillaire. En avant. La surface.

Orbitaire. De l'ingot. C'est divisé.

En deux parties. Par une crête. Verticale.

On appelle. La crête. Lacrimal.

Postérieur. En avant. De cette crête.

Lacrimal. On trouve. La boutière.

Lacrimal. La boutière. Lacrimal.

On va surloger. Le sac lacrimal. En avant.

La crête. Lacrimal. Antérieur.

Qui donne insertion. Au tendon direct. De l'également.

Papivral. Inter. Cette paroi.

Contracte des rapports. Avec le sinus. Fimidal.

Et le sinus. Fimidal. En arrière.

La crête. Lacrimal. Antérieur.

Entre. Deux crêtes. Se trouve.

La boutière. Lacrimal. La boutière.

Lacrimal. On va surloger. Le sac lacrimal.

On va surloger. Le sac lacrimal. Oui.

La crête. Lacrimal. Antérieur.

Donne. Insertion. Au tendon direct.

De l'également. Papivral. Inter.

En avant. Après avoir vu les quatre parois de l'orbite osseux. Nous allons maintenant étudier la base de l'orbite.

Et la paxe orbitale. La base de l'orbite. Elle est.

Elle s'est conscrute par le robot orbitaire. Qui comporte le robot orbitaire supérieur. Il est constitué par le frontal.

Le robot orbitaire supérieur. Il est constitué par le robot. Le frontal.

Le robot. Le robot orbitaire. Externe.

Il est divisé. En deux parties. La partie haute.

Il est composé par la surface orbitale de l'os frontal. La partie inférieure. Au bas.

Il est composé par le corps extérieur de l'os malaire. Le robot orbitaire inférieur. Il est formé en dehors.

Par l'os malaire. Et en dedans. Par la pousse pyramidal.

Vaisselle supérieure. Le sommet. Le sommet de l'orbite.

Pour. La pexe. Il répond à l'extrémité interne.

De la fissure orbitaire supérieure. Un peu au-dessus. Et en dedans de lui.

Il se trouve. L'orifice du canal optique. Il est formé.

Par la face orbitaire. Rectangulaire du corps de celui-ci. Deux orifices.

S'ouvrant. Dans la cavité arrière. Qu'on appelle.

Le trochène interne. Et un autre. Inférieur.

Externe. Les orifices de l'orbite. D'abord.

Le canal optique. C'est un. L'orifice.

Ovale. Creusé. Dans la base.

De la petite aigle suinoïde. Dans la pexe orbitaire. Le trochène optique.

Représente. L'orifice antérieur. Du canal optique.

Qui fait communiquer. L'étage. Antérieur.

De la base du crâne. Et l'orbite. Il livre.

Passage. Au nerf optique. Et à la terre.

Organique. Entre. Le trochène optique.

Et la partie large. De la fronte suinoïdale. Il existe.

Les tubercules. Pour l'insertion. Au fond de l'osine.

On verra par la suite. Aux insertions. Du muscle.

Sur cette coupe. De la pexe orbitaire. Au fond.

De l'orbite. Vous voyez ici. Vous voyez ici.

Le tros. Le tros optique. C'est à l'orifice.

Deversion. Du canal optique. Ici.

C'est la fissure orbitaire. Supérieure. Donc le canal optique.

Le tros optique. Et la fissure. Orbitaire.

Supérieure. C'est pareil. On appelle.

Par deux structures. On appelle. Le structure optique.

La structure. La fissure. Orbitaire.

La fissure. Orbitaire. Supérieure.

Elle est. Creusée. Entre.

La grande. Et la petite. La fissure.

Orbitaire. Supérieure. Il a une forme.

De masse. Grosse. Extrémité.

Inférieure. Et interne. La fissure.

Orbitaire. Supérieure. La fronte.

Finiale. Et destinée. Entre.

La petite. Et la grande. La partie.

C'est ronfler. Un ferro. Interne.

Divisé. Par l'anodosine. Et traversé.

Par. A l'intérieur. De l'anodosine.

A l'intérieur. De l'anodosine. Le nerf.

Nasal. Le nerf. Moteur.

Oculaire. Commun. Supérieure.

Le nerf. Moteur. Oculaire.

Extérieur. Le nerf. Cisse.

En dehors. De l'anodosine. Le nerf.

Pacifique. Le nerf. Le nerf.

Frontal. Et. Le nerf.

Lacrimal. Sur ce schéma. De la fissure.

Orbitaire. Se font. Une grosse massue.

A extrémité. Inferior. Inferior.

Extrême. Se font. Des virules.

A extrémité. Inferior. Albert.

Il est divisé. En deux parties. Par.

L'anodosine. L'insertion. De l'anodosine.

Qui donne. A l'origine. Des muscles.

Aux couleurs. Communes. Cette anodosine.

Divise. La fissure. Orbitaire.

En deux parties. A l'intérieur. L'anodosine.

Livre. Passage. La fissure.

Orbitaire. Donne passage. Au grand supérieur.

Le nerf. Montant aux couleurs communes. Le nerf.

Trois. Le grand supérieur. Et la.

Le nerf. Cisse. Le nerf.

Montant aux couleurs externes. Et le nerf. Nasal.

En dehors. De l'anodosine. Toujours dans la fissure.

Orbitaire. Supérieur. Le nerf.

Lacrimal. Le nerf. Frontal.

Le nerf. L'anodosine. La veine.

Veine. Ophtalmique. La fissure.

Orbitaire. Intérieure. Donc.

Il est limité par les os. De. L'os.

Funita. L'os. Maxillaire.

Et l'os. Parataille. Il s'étouffe.

Entre la paroi latérale. Et le plancher de l'orbite. Il fait communiquer l'orbite.

Avec la force. pas latines. Les trous hythmoïdales, hythmoïdaux antérieurs et postérieurs, ils livrent passage aux affaires et aux nerfs hythmoïdaux, le nerf antérieur et le nerf postérieur.

Vous voyez ici sur cette courbe de la paroi médienne d'orbite, ici c'est les orifices où le trou hythmoïdale postérieur et le trou hythmoïdale antérieur. Donc ces trous, il faut ramener le trou dans la paroi médienne de l'orbite. Quelques exemples des applications pratiques de la pathologie orbitaire sur tous les fractures.

Ici, c'est une fracture de plancher de la paroi inférieure avec incarceration du muscle, de la graisse orbitaire et au-dessus, voilà une incarceration de trou inférieur dans le foyer fracturé. Ici, quelques exemples de pathologies tumorales. Ici, une fracture de planche de l'orbite.

Ici, une prosthèse tumorale antérieure. Ici, une myxophthalmie axiale, donc un conflit entre le contenu, c'est-à-dire l'orbite, et le contenu, c'est-à-dire la graisse, le muscle, les nerfs et le globulaire. Alors, on passe par la suite à la vascularisation de l'orbite.

La vascularisation de l'orbite est assurée par deux systèmes artériels. Le système chaotique interne par l'artère optanique, le système chaotique interne par l'artère afra-orbitaire. L'artère optanique prend en charge la quasi-totalité de l'apport artériel de l'orbite.

Le retour inné est assuré par les veines optaniques. Alors, la vascularisation de l'orbite provient principalement de l'artère chaotique interne. La vascularisation artérielle de l'orbite provient essentiellement de l'artère optanique et une branche de l'artère chaotique interne.

Elle pénètre dans l'orbite à le canal optique, dont de nombreuses branches collatérales destinées à vasculariser le globulaire par l'attraction de l'artère ciliaire et aux annexes, les muscles oculomoteurs et les popules. Une branche collatérale de l'artère chaotique interne. L'artère optanique présente trois segments.

Un segment intracranial et un segment intracranial dans le canal optique et un segment intra-orbitaire, c'est-à-dire dans l'orbite. Son origine, donc il prend naissance au niveau de la face antéromédienne de l'artère chaotique interne située au-dessus du processus clinique antérieur. Cette origine est sujette à de nombreuses variations.

Son trajet présente trois segments, donc un segment intracranial et de longueur variable de 3 à 15 mm. L'artère naissant directement de la carotide interne au trajet ischioïneux puis rectiligne. À ce niveau, l'artère est en rapport avec la face inférieure de l'orbite.

Le segment intracanal est très courte. À ce niveau, l'artère chemine au-dessous du neurone. Le segment intra-orbitaire comporte trois parties.

Un segment latéraux optique est placé en dehors d'un neurone optique et à sa partie inférieure. Il y a un segment supra-optique. L'artère croise le neurone optique en passant au dessus du nerf et un segment médio-optique.

L'artère est en-dedans par rapport au nerf optique. Après avoir donné naissance aux nombreuses coules latérales destinées à la vascularisation de l'orbite et du contenu orbitaire, l'artère optanémique perfore le système orbitaire au niveau de l'ongle supérieur interne de l'orbite et se termine en donnant naissance à l'artère angulaire et quelques branches frontales destinées à vasculariser l'orbite. L'artère optanémique se termine au niveau de l'ongle supérieur interne.

Après avoir perforé le septum orbitaire, elle donne naissance à l'artère angulaire et quelques branches collatérales destinées à vasculariser la peau de la femme. L'artère optanémique donne des branches collatérales très nombreuses, variables en fréquences, en origine, en nombre. Thématiquement, on distingue deux grandes groupes, les artères à destinée optique, c'est-à-dire pour la vascularisation oculaire, la vascularisation neurotique et la vascularisation optique, à l'artère centrale de la rétine, les artères axillaires longues et les artères neurotiques.

Et puis les branches à destinée annexiaires, c'est-à-dire pour les annexes de globes oculaires, à savoir les artères supra-orbitaires, les thémoidales, l'artère lacrymale, les artères musculaires et les artères palpébrales. Pour l'artère centrale de la rétine, c'est une artère constante. L'origine prend naissance au niveau de l'artère ophtalmique directement dans ses contrôles sondécaires.

Cette origine est située au-dessous et en dehors du neurotique. Elle s'immine le long de la face inférieure du neurotique. Puis elle pénètre à l'intérieur du neurotique et s'immine au niveau de la papille par des branches terminales.

Voici l'artère ophtalmique qui est dans l'artère centrale de la rétine qui pénètre à l'intérieur du neurotique pour se terminer au niveau de la papille optique. Voilà la papille optique, l'artère centrale de la rétine, qui se divise à sa sortie au niveau de la papille optique par des branches temporales supérieures, temporales inférieures, nasales supérieures et nasales inférieures. Ici, vous voyez, l'artère centrale de la rétine est à l'intérieur du neurotique.

Les artères du neurotique sont nombreuses et grêles. Schématiquement, on distingue deux groupes, celles qui sont issues du segment intra-canaulaire, c'est-à-dire à l'intérieur du canal optique, et celles qui sont issues du segment intra-orbitaire de l'artère ophtalmique. Les artères ciliaires postérieures, deux groupes d'artères ciliaires qui participent au grand sac artériel de l'iris, une médiane et une latérale, et les artères ciliaires courtes, très nombreuses, destinées à la vascularisation de la coromide.

Vous voyez ici la participation de l'artère ophtalmique, la vascularisation de la rétine et du globe auriculaire par l'intermédiaire de l'artère centrale de la rétine qui passe à l'intérieur du neurotique et départ des artères ciliaires courtes qui participent à la vascularisation de la coromide et de la rétine. Par contre, les artères ciliaires longues participent à la vascularisation de l'iris, c'est-à-dire le grand sac artériel de l'iris et la vascularisation de la branche optique et des muscles oculomoteurs. Une autre branche latérale de l'artère ophtalmique, c'est l'artère lacrymale, donc destinée à la vascularisation de la glande lacrymale principale.

Donc, elle prend naissance au niveau de l'artère ophtalmique dans sa partie latérale optique, rarement au niveau de l'artère méningé-moyen. Donc, son trajet, il passe sur le flanc supralatéral de l'artère ophtalmique, ce trajet donc oblique en haut, en avant et en dehors vers la paroi latérale de l'artère ophtalmique. À ce niveau, l'artère aura pour optique voie à vers le lacrymale au long du flanc supralatéral de l'orbite.

Il se termine au niveau du pôle postérieur de la glande lacrymale. D'autres branches latérales de l'artère ophtalmique, c'est l'artère supraorbitaire. Elle prend naissance au niveau de la face supérieure de la porte sommitaire optique de l'artère ophtalmique.

Son trajet, il est atracolique, il se dirige en haut et en avant dans l'agresse orbitaire chimine, le long de la face supérieure du muscle, le releveur de la poupière chimine. Au niveau du muscle, le releveur de la poupière supérieure et l'oblique supérieur. Les artères etomidaux antérieurs et postérieurs sont les branches collatérales de l'artère ophtalmique.

En antérieur, elle prend origine au niveau de ses moments médiaux optiques de l'artère ophtalmique. Elle passe entre le muscle supérieur et le releveur de la poupière supérieure. Pour se terminer, on donne des branches pour la durmère de la lame criblée des forces nasales, le muscle oblique supérieur et le muscle en haut de la poupière.

Pour les artères etomidaux antérieures, elles font naissance au niveau des moments médiaux optiques de l'artère ophtalmique. Elles terminent à la face supérieure de l'artère ophtalmique et pour se terminer au niveau de les forces nasales. Les artères musculaires sont d'autres branches collatérales de l'artère ophtalmique.

Les artères musculaires inférieures sont constantes, volumineuses et prennent naissance au niveau de la face inférieure de la portion médio-optique de l'artère ophtalmique. Elles suivent un

trajet en se plongeant vers le plancher pour vasculariser les muscles oculomoteurs. Les artères palpébraux, en nombre de deux, sont des branches collatérales de l'artère ophtalmique supérieure et inférieure.

Elles sont destinées aux deux paupières, la paupière supérieure et la paupière inférieure. Et chaque artère se divise en deux branches, chaque division de moments supérieure pour les artères ophtalmiques. Les branches terminantes de l'artère ophtalmique sont de deux types.

L'artère angulaire, qui est une branche terminante de l'artère ophtalmique, est située au niveau de l'angle supraromédien et descend le long de la racine du nez pour s'anastomoser avec la branche terminante de l'artère faciale, c'est-à-dire l'artère frontale de la face inférieure. Le système carotidien extérieur participe aussi à la vascularisation de l'orbite. Par l'intermédiaire de l'artère infrarobitaire, qui prend naissance au niveau de l'artère maxillaire, et qui chemine dans le sillon infrarobitaire de la branche de l'orbite, dans le canal infrarobitaire, et se termine en vasculariser la région de l'orifice supérieur du canal, dans l'acné nasal.

Le deuxième artère du système carotidien extérieur est l'artère ménageur lacrymal, qui prend naissance au niveau de l'artère ménageur moyen, et qui pénètre dans la cavité orbitale par la paroi latérale. La vascularisation veineuse de contenus orbitaux est assurée par trois veines. La veine ophtalmique supérieure est déformée par deux racines, supérieure et inférieure, et puis la veine ophtalmique moyenne, issue des veines musculaires, droite, médiane, latérale et inférieure, puis la veine ophtalmique inférieure, issue des veines musculaires, obliques inférieurs, du muscle droit inférieur et du muscle latéral.

Alors, pour conclure, il faut retenir en pratique que l'évaluation d'une atteinte orbitaire doit distinguer des lésions intra-orbitaires, des lésions péro-orbitaires et intra-oculaires. Cette distinction est la base du diagnostic clinique d'une pathologie orbitaire, un diagnostic différencié. L'évaluation doit commencer par un examen clinique, donc un examen clinique méthodique, par interrogatoire, à la recherche du beurre, de l'armement, des ronneries et des pousses nids.

L'inspection au cas de paralysie de globulaire, des ophtalmies axiales, obliques, une fraction de l'ongle interne, des signes inflammatoires autour du globulaire et de l'orbite. Il faut mesurer l'accuracie visuelle aussi bien de loin que de près, et les signes endocriniens et neurologiques par un examen oral et un examen endocrinien. L'apprentissage de robots orbitaires, l'apprentissage de robots orbitaires, bien sûr, le globulaire et les points sublimes.

L'imagerie de l'orbite, elle est orientée dans le domaine de la clinique. L'échographie oculaire pour la biométrie, c'est-à-dire l'angle axial inter-orbital du globulaire. Des DEM orbitaires, c'est une gestion éliminée.

Et l'IRM, l'ange graphique, l'échographie et la misogynie. Je vous remercie.